

2. Datenfelder MIND (inklusive Plausibilitäten und Abhängigkeiten)

MINIMALER NOTFALLDATENSATZ MIND 7.1						Release 1: 28.08.2026	
Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach/ Mehrfach E/M	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: Strukturdaten							
Protokolltyp	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Typ des verwendeten Protokolls: + NA für Notarztdokumentation + RD für Rettungsdienstdokumentation Sollte in Stammdaten fest dem Rettungsmittel/Personal zugewiesen werden. Beim Wechsel von Dokumentations-Pads zwischen Fahrzeugen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das korrekte Rettungsmittel mit der ihm zugeordneten Projekt-ID und der richtige Protokolltyp ausgewählt sind.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen z.B. ProjektID, Rettungsmitteltyp, Einsatzort, Qualifikation Personal.	
Standortkennung	Nein	E	Antifälscher Gemeindegemeinschaft des RM-Standortes BL-LK (Bundesland/Landes-Rettungswache; Bundesland und Landkreis jeweils nach Vorgaben des Gemeindegemeinschafts)	NA + RD	Antifälscher Gemeindegemeinschaft des Rettungsmittel-Standortes.		-2
ProjektID	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Standortspezifische Nummer, die von einer zentralen Stelle vergeben und verwaltet wird. Standortverantwortliche sind aufgefordert, sich dort um eine ID-Zuteilung zu bemühen. Einmalig in Stammdaten einzupflegen.	Prüfung auf Plausibilität, z.B. Leitstelle, Einsatzort, Rettungsmitteltyp, Protokolltyp	
Leitstelle	Ja	E	Landeskennung der Heimatleitstelle (z.B. S für Stuttgart, OG für Offenburg)	NA + RD	Für einen Standort immer konstant und sollte automatisiert beim Export zugeordnet werden. Einmalig in Stammdaten einzupflegen.	Prüfung auf Plausibilität, z.B. ProjektID und Leitstelle	
Softwarekennung	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Kennung des Dokumentationssystems des Rettungsmittels und der Software-Version	NA+RD	Identifikation des Dokumentationssystems und der Software-Version, mit der die Einsatzdaten erzeugt wurden.	Pflichtfeld in BW	-2
Kapitel: Rettungsnotrufdaten							
Primärschlüssel	Ja	E	eindeutiger Primärschlüssel für alle Fälle pro Jahr Zeichenkett. 20	NA + RD	Innerhalb eines Leitstellenbereiches darf in einem Kalenderjahr kein Primärschlüssel mehrfach vergeben werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass im NA-Protokoll die NA-Auftragsnummer und im RD-Protokoll die RD-Auftragsnummer verwendet wird! Bei mehreren Patienten in einem Einsatz, soll von der "Heimatleitstelle" für jeden Patienten eine separate Auftragsnummer zugeteilt werden. Diese ist ggf. anzufordern. Dort wo dies leitstellen-/abrechnungsgemäß nicht möglich ist, soll der Primärschlüssel im jeweiligen Datensatz durch ein eindeutiges Suffix gekennzeichnet werden (bspw. Auftragsnummer der Leitstelle ergänzt mit -01 bis -99 oder mit -A bis -Z)		
Einsatzort	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Art des RD-Einsatzortes/Notarzteinsatzortes Für die Auswahl des zutreffenden Codes ist der Status zum Zeitpunkt der Alarmierung des dokumentierenden Rettungsmittels durch die Leitstelle maßgeblich. (d.h. in einem NA-Protokoll dürfen unter Einsatzort nur Ausprägungen mit dem Inhalt "mit (physisch anwesendem) NA" dokumentiert werden, auch wenn der NA nachgefordert wurde und die primäre Alarmierung des RTW ohne NA erfolgte. Im RD-Protokoll dürfen - sofern bei Alarmierung des RTW (noch) keine Alarmierung eines NATNA erfolgt ist - unter Einsatzort nur Ausprägungen mit dem Inhalt "ohne NA" dokumentiert werden, auch wenn es später zu einer NA-Nachforderung kam.) Einsatzorten "mit (physisch anwesendem) NA" (01, 03, 05, 07) bzw. "mit...TNA" (02, 03, 06, 07) sind immer dann auszuwählen, wenn bis zum Zeitpunkt der Alarmierung des dokumentierenden RM ein NA oder ein TNA ebenfalls alarmiert wurden. Dienstfahrt und Pausen sind organisatorische Einsatzarten, die in keinem Bezug zu einem beabsichtigten oder tatsächlichen Patientenkontakt stehen (beispielsweise Fahrt in die Kfz-Werkstatt). Ein Materialtransport, für den ein Patientenbezug hergestellt werden kann (z.B. Transport eines Inkubators durch einen RTW zu einem anderen Einsatz) ist nicht mit Dienstfahrt zu kodieren. Wenn ein RTW von der Leitstelle einen Krankentransportauftrag erhalten hat, ist als Einsatzort Krankentransport auszuwählen.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Wenn Protokolltyp NA, dann ist Einsatzort GLEICH (04 ODER 06 ODER 10) unzulässig.	
Gemeindegemeinschaft	Nein	E	Antifälscher Gemeindegemeinschaft des Einsatzortes	NA + RD	Quelle ist das Statistische Bundesamt. Der Antifälscher Gemeindegemeinschaft (AGS) ist ein 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen)		-2
Postleitzahl	Nein	E	Postleitzahl des Einsatzortes	NA + RD	PLZ des Einsatzortes - diese ist bei Einsätzen am Wohnort des Patienten zumeist der Versichertenkarte zu entnehmen.		-2
GeoEinsatzort	Nein	E	Geokoordinaten des Einsatzortes GPS-Geo-Koordinaten im Decimalformat (WGS 84)	NA + RD	Die Koordinaten werden in der Reihenfolge Breitengrad, Längengrad mit Komma getrennt angegeben. Format: 99.999999;99.999999		-2
EinsatzortTyp	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Beschreibung des Einsatzortes. Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze	Pflicht wenn: Einsatzort NICHT (11 ODER 12)	-2

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
RDTransport	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Welches Rettungsmittel hat den überwiegenden Anteil des Transports des Patienten (hinsichtlich der Transportbreite) durchgeführt? "Transport durch NAW" ist nur auszuwählen, wenn es sich bei dem RM von vornherein um einen NAW gehandelt hat (ein RTW, bei dem der NA den Transport begleitet, bleibt ein RTW) Bei gemeinsamem Einsatz von RTW und NA identische Dokumentation in RD- und NA-Protokoll	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. • Bei Auswahl 01 wird KeinTranspMiPat zum Pflichtfeld • Bei Auswahl 02 wird KeinTranspOhnePat zum Pflichtfeld Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2
AerztBegleit	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Ärztliche Begleitung Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze Wurde der Transport ärztlich begleitet? Wenn ja, von wem? Pflicht für NA- und RD-Protokolle bei Einsätzen mit durchgeführten Transport Bei gemeinsamem Einsatz von RTW und NA identische Dokumentation in RD- und NA-Protokoll	Wenn EinsatzArt GLEICH (11 ODER 12), sind sämtliche Inhalte in RDTransport außer -2 unzulässig. Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen.	-2
NotarztNachgefordert	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Physisch anwesender Notarzt wurde nachgefordert Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Betrifft nur die Nachforderung eines physisch anwesenden Notarztes (nicht eines Telenotarztes). NA: Wurden Sie nachgefordert? RD: Haben Sie einen Notarzt nachgefordert? Falls unbekannt "nein" dokumentieren Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze wenn bei Protokolltyp RD eine Einsatzart ausgewählt wurde, die eine primäre Alarmierung eines (physisch anwesenden) NA zum Ausdruck bringt (01, 03, 05, oder 07) ist die Dokumentation NotarztNachgefordert-ja unzulässig.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12) Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND EinsatzArt GLEICH (01 ODER 03 ODER 05 ODER 07), dann ist NotarztNachgefordert = 01 unzulässig.	-2
TNANachgefordert	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Tele-Notarzt wurde nachgefordert Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Betrifft nur die Nachforderung eines Telenotarztes (nicht eines physisch anwesenden Notarztes). NARD: Haben Sie einen TNA nachgefordert? Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze wenn bei Protokolltyp RD eine Einsatzart ausgewählt wurde, die eine primäre Alarmierung eines TNA zum Ausdruck bringt (02, 03, 06, oder 07) ist die Dokumentation TNANachgefordert-ja unzulässig. Pflicht für Einsätze ohne Transport trotz Patientenkontakt	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12) Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 03 ODER 06 ODER 07), dann ist TNANachgefordert = 01 unzulässig.	-2
KeinTranspMiPat	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Grund für Einsatz ohne Transport trotz Patientenkontakt Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	nur für Einsätze ohne Transport, aber <u>mit</u> Patientenkontakt <u>nicht</u> für Einsätze ohne Patientenkontakt (diese sollen unter KeinTranspOhnePat dokumentiert werden) 02 = primäre Todesfeststellung (ohne CPR); keine Todesfeststellungen ohne Reanimation (Erstbefunde sind erforderlich, Abschlussbefunde/Diagnosen/RD-Maßnahmen sind nicht erforderlich.) Der Grund für die nicht durchgeführte Reanimation muss in Feld Reanimationssituation angegeben werden! Sobald Reanimationsmaßnahmen durchgeführt wurden, darf im Feld KeinTranspMiPat nicht die 02 ausgewählt werden und in Feld Reanimationssituation muss 04 gewählt werden. Erfolgreiche Reanimationen werden mit dem Code 03 = Patient im Einsatzverlauf verstorben dokumentiert. Wenn Reanimationsmaßnahmen durch andere erfolgen und bei Eintreffen des eigenen RM der ROSC fortbesteht, darf im Feld KeinTranspMiPat nicht die 02 ausgewählt werden und in Feld Reanimationssituation muss 04 gewählt werden. Die Dokumentation über das Vorliegen eines Einsatzes ohne Transport trotz stattgehabtem Patientenkontakt erfolgt in Kombination mit dem Feld RDTransport (01 = kein Patienten-transport, trotz Patientenkontakt).	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: RDTransport NICHT 01, sind sämtliche Inhalte in KeinTranspMiPat außer -2 unzulässig.	-2
KeinTranspOhnePat	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Grund für Einsatz ohne Transport, da kein Patientenkontakt Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht für Einsätze ohne Transport wegen fehlendem Patientenkontakt nur für Einsätze ohne Patientenkontakt; nicht für Einsätze mit Patientenkontakt ohne Patienten-transport (diese müssen unter KeinTranspMiPat dokumentiert werden) Die Dokumentation über das Vorliegen eines Einsatzes ohne Transport aufgrund fehlenden Patientenkontakts erfolgt in Kombination mit dem Feld RDTransport (02 = kein Patienten-transport, da kein Patientenkontakt).	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Pflicht wenn: RDTransport GLEICH 02 Wenn RDTransport NICHT 02, sind sämtliche Inhalte in KeinTranspOhnePat außer -2 unzulässig.	-2
DokRM	Ja	E	Rettungsmitteltyp des dokumentierenden Rettungsmittels Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Codierung des Rettungsmittels, welches den Einsatz abwickelt und dokumentiert.	Wenn Protokolltyp NA dann sind DokRM GLEICH (02 ODER 03 ODER 10 ODER 11 ODER 12 ODER 15 ODER 17 ODER 18 ODER 20) unzulässig	
SoSeiRM	Nein	M	Rettungsmitteltypen des/der beteiligten Rettungsmittels Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Codierung der am Einsatz beteiligten Rettungsmittel Wird in der Regel durch die Leitstelle dokumentiert.	Wenn Protokolltyp RD dann sind DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 13 ODER 14 ODER 16 ODER 19) unzulässig.	-2
AerztQualifikation	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Fachrichtung/Qualifikation des Notarztes/Transportarztes Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Pflicht für NA-Protokolle, außer für Dienstfahrten oder Pauseneinsätze Es ist immer die Fachrichtung/Qualifikation des dokumentierenden Arztes einzutragen	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2
StatusPersonal	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Status des Personals Wertefliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Qualifikation des höchstqualifizierten Mitarbeiters auf dem Rettungsmittel. Beim notarztbesetzten Rettungsmittel die des Notarztes, beim nicht NA-besetzten Rettungsmittel die des Rettungsdienstmitarbeitenden. Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze	Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2
Kapitel: ZahlenEinsatzkategorie Einsatzdatum	Ja	E	Einsatzdatum	NA + RD	Einsatzdatum bezieht sich auf den Zeitpunkt der Alarmierung.	(siehe Kapitel ist immer Pflicht)	

Kapitel/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MINO
Symptombeginn/Vor24h	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Bestehen die Symptome länger als 24 Stunden oder ist dies unbekannt? Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht für NA-Protokolle bei Primäreinsätzen, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR) oder eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle bei Primäreinsätzen ohne erkennbare Beteiligung eines physisch anwesenden NA, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR) oder eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinsatzArt GLEICH (01 ODER 03) UND KeinTranspMitPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinsatzArt GLEICH (03 ODER 04) UND NotarztWachegefordert GLEICH 02 UND KeinTranspMitPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08)	-2
Symptombeginn	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Ereigniszeitpunkt, Unfallzeitpunkt, Kollapszeitpunkt, Zeitpunkt Symptom/Beschwerdebeginn	NA + RD	Wenn der Symptombeginn bzw. Unfall-/Ereignis-/Kollapszeitpunkt (bekannt oder geschätzt) innerhalb von 24 Stunden vor Alarmierung liegt, ist die Uhrzeit hier anzugeben.	Pflicht wenn: SymptombeginnVor24h GLEICH 02 UND EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
Symptombeginn/Geschicht	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Ist der Symptombeginn geschicht oder geschätzt?	NA + RD	Gibt es belastbare Angaben zum Symptombeginn durch Patienten, Angehörige, Zeugen, etc.?	Pflicht wenn: SymptombeginnVor24h GLEICH 02 UND EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	-2
ZeitNotfallmeldung	Nein	E	Zeitpunkt Eingang Notfallmeldung in LST	NA + RD	Definition: Zeitpunkt des Anrufes (Aufschaltzeitpunkt aus Leitstellen-Datensatz) Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-03; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitAlarm	Nein	E	Zeitpunkt Alarm/Auftragsvergabe	NA + RD	Definition: Auslösung Alarm durch LST Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-03; 00.000-0 1:00
ZeitAusweichen	Nein	E	Zeitpunkt Abfahrt/fähig Standort Status 3	NA + RD	Definition: Ausweichen des einzelsitzigen Rettungsmittels (Besatzung komplett) Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitAnkunft/Einsatzort	Nein	E	Zeitpunkt Ankunft Einsatzort Status 4	NA + RD	Definition: Ankunft des dokumentierenden RM am Einsatzort. Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitAnkunft/Patientenkontakt	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Zeitpunkt Ankunft Patient	NA + RD	Definition: Ankunft der Rettungsmittelbesatzung beim Patienten bzw. Beginn der Übernahme des Patienten bei Sekundäreinsätzen. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfeleistung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport oder um eine Hilfeleistung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND NICHT (EinsatzArt GLEICH 10 ODER KeinTranspMitPat GLEICH 05 ODER 08))	1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitTransportbeginn	Nein	E	Zeitpunkt Transportbeginn Status 7	NA + RD	Definition: Beginn des Patiententransportes. Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitEintreffen Transportziel	Nein	E	Zeitpunkt Eintreffen Transportziel Status 8	NA + RD	Definition: Fahrzeug trifft am Transportziel ein Wird in der Leitstelle dokumentiert.		1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitJahrgang/Patient	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Übergabe des Patienten an Weiterbehandler	NA + RD	Definition: Übergabe an Personal der Zielklinik/Praxis oder Übergabe an anderes Rettungsmittel (Übergang der Verantwortung für den Patienten). Bei Einsätzen ohne Patiententransport optional als Abschluss der Behandlung. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat (Übergabezeitpunkt an Klinik bzw. an anderes transportierendes RM, wenn dokumentierende NA den Transport nicht begleitet). Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport durch das dokumentierende RM stattgefunden hat und keine notwendige Begleitung erfolgt bzw. die Begleitung ausschließlich durch einen NA durchgeführt wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AerztBegleit ENTHALT (00 ODER 03) UND AerztBegleit ENTHALT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98)	1902-02; 02/27-02; 00.000-0 1:00
ZeitEinsatzende	Ja	E	Zeitpunkt Einsatzende	NA + RD	Definition: Einsatz ist abgeschlossen (inkl. aller mit dem Einsatz zusammenhängenden Arbeiten wie z.B. Desinfektionstillstände und Dokumentation).		

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: Patientendaten					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich beim dokumentierten Rettungsmittel um einen Krankentransport, eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND NICHT (EinsatzArt GLEICH 10 ODER KeinTranspMitPat GLEICH 05 ODER 98)	
Alter	Ja	E	Alter des Patienten Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Spezifische Dokumentation für Kinder unter einem Monat (siehe Codes) Angabe in vollendeten Jahren und Lebensmonaten (Bezugspunkt ist die Eintrittszeit). Ab dem 29. Lebenstag gilt der erste Lebensmonat als vollendet. In diesem Fall ist der Wert 000:01 zu übermitteln Wenn das Alter nicht bekannt ist, soll es geschätzt werden. Auch in seltenen Fällen, wenn die Schätzung des Alters schwierig ist, soll trotzdem eine grobe Vermutung dokumentiert werden	Wenn Kapitel "Patientendaten" Pflicht, dann ist 222:00 unzulässig	222:00
ValidesAlter	Ja	E	Ist das Alter gesichert oder geschätzt? Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "Patientendaten" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Geschlecht	Ja	E	Geschlecht des Patienten Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "Patientendaten" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: ErsteMesswerteUndBefunde			Erste gemessene Werte bzw. erste erhobene Befunde		Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine Hilfestellung, eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels oder um eine Verlegung mit physisch anwesendem Notarzt handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMitPat NICHT (05 ODER 06) UND EinsatzArt NICHT (05 ODER 07 ODER 10)	
Bewusstsein1	Ja	E	Bewusstseinslage Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Es ist die jeweils beste Ausprägung zu wählen	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
GlasgowComaScale1	Ja	E	Glasgow Coma Scale Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei Seitendifferenz bessere Seite	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
NeurologischeAuffälligkeiten1	Ja	M	Neurologische Auffälligkeiten Werteliste siehe Tabellenblatt	NA + RD	+ aNHSS-EMS Items und BEFAST werden abgebildet. + die Dokumentation von Schweregraden und der Körperseite ist im MIND nicht vorgesehen	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 00...1 oder 99 sind unzulässig.	-2
SystolischerBlutdruck1	Ja	E	Systolischer Blutdruck Messwert in mmHg	NA + RD	Bedeutet RR-Messung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EKGBefund1	Ja	M	EKG-Befund Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur die Ausprägungen dokumentiert werden, die zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung zutreffend waren (nicht diejenigen in weiteren Verlauf). Für QS wird EKG als durchgeführt gewertet, wenn Angabe ungleich -1.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit...1 oder 99 sind unzulässig.	-2
Herzfrequenz1	Ja	E	Herzfrequenz Messwert in /min	NA + RD	Vom Monitor abgelesene Herzfrequenz pro Minute (ggf. palpatorisch oder pulsoximetrisch bestimmte Pulsfrequenz, wenn kein EKG abgebildet wurde).	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Werte GRÖßER 0 bei EKGBefund1 GLEICH 09 sind unzulässig.	-2
Atemfrequenz1	Ja	E	Atemfrequenz Messwert in /min	NA + RD	Ausgehörte oder vom Monitor abgelesene Atemfrequenz pro Minute.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Werte GRÖßER 0 bei Atmung1 GLEICH 08 sind unzulässig.	-2
Sauerstoffsättigung1	Ja	E	Sauerstoffsättigung Messwert in %	NA + RD	Bedeutet Pulsoxymetrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999. Der Erstbefund der Sauerstoffsättigung sollte möglichst vor Therapie mit Sauerstoff ermittelt werden.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Rekapillarisierungszeit	Ja	E	Rekapillarisierungszeit Messwert in s	NA + RD		Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Schmerzempfinden1	Ja	E	Schmerzempfinden nach Numerischer Rating Scale (NRS) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Erstbefund des Schmerzempfindens vor dem Einleiten von Maßnahmen.	Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Wenn Bewusstseint GLEICH 05, dann ist Schmerzempfinden GLEICH (01 bis 10) unzulässig.	-2
Schmerz erleben	Nein	E	Schmerz erleben Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Mit dem Schmerzerleben soll der subjektive Bedarf eines Patienten nach einer Schmerztherapie zum Ausdruck gebracht werden und damit deren Indikation dokumentiert werden.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen.	-2
Blutzuckermesswert	Ja	E	Blutzucker Messwert in mg/dl bzw. mmol/l Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Blutzuckermessung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich, 997, 998 oder 999	Bei Auswahl 0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0 wird BlutzuckerEinheit zum Pflichtfeld Wenn Kapitel "ErsteMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal/ Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Pausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
BlutzuckerEinheit	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Ermöglicht die Dokumentation der im jeweiligen Bundesland / Rettungsdienstbereich gültigen Maßeinheit für den Blutzuckerwert	Pflicht wenn: Blutzuckerwert1 ODER Blutzuckerwert2 ENTHÄLT (0 bis 900 bzw. 0.0 bis 50.0)	-2
Temperatur		E	Temperatur Messwert in Grad Celsius	NA + RD	Bedeutet Temperatur-Messung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 99.9. Keine explizite Ortsangabe, wenn möglich zentral (Tympanon)	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Atmung?	Ja	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur die Ausprägungen dokumentiert werden, die zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung zutreffend waren (nicht diejenigen im weiteren Verlauf).	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Hautbefunde	Ja	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Psychst	Ja	M	Psychischer Zustand Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur die Ausprägungen dokumentiert werden, die zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung zutreffend waren (nicht diejenigen im weiteren Verlauf).	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Pupillenweite1	Ja	E	Pupillenweite	NA + RD	Es ist die klinisch relevanteste Ausprägung zu dokumentieren	Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Lichtreaktion1	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "ErstMesswerteUndBefunde" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EICOWert1	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Kapnometrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999. Pflicht, wenn eine Atemwegssicherung oder eine maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) dokumentiert ist.	Pflicht wenn: Airway GLEICH (03 ODER 05 ODER 07) ODER Atemunterst GLEICH 05	-2
Kapitel: Erstbefunde/Verlegung			Werteliste siehe Tabellenblatt Codes		Pflicht für NA-Protokolle, wenn eine Verlegung mit physisch anwesendem NA oder ein Intensivtransport stattfindet. (Für RD-Protokolle ist dieses Kapitel nie Pflicht.)	Die Abhängigkeiten des gesamten Kapitels betreffen nur das Bundesland Baden-Württemberg Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Einsatzort GLEICH (05 ODER 07 ODER 08)	
VBeatmung	Ja	E	Beatmung (außer Hembbeatmung)	NA		Wenn Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
VBeatmungDetail	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Differenzierte Beatmung bedeutet FZ2 > 0.4. Pflicht, wenn im Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" eine Beatmung dokumentiert wurde.	Pflicht wenn: VBeatmung GLEICH 01 Wenn VBeatmung GLEICH 01, dann ist -2 unzulässig.	-2
KatecholaminPflicht	Ja	E	Katecholaminpflichtigkeit	NA		Wenn Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
KatecholaminTherapie	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Differenzierte Katecholamin-Therapie bedeutet mehr als ein Katecholamin. Pflicht, wenn im Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" eine Katecholaminpflichtigkeit dokumentiert wurde.	Pflicht wenn: KatecholaminPflicht GLEICH 01 Wenn KatecholaminPflicht GLEICH 01, dann ist -2 unzulässig.	-2
FortlaufendSedierung	Ja	E	fortlaufende Sedierung/Narkose	NA		Wenn Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
VigilanzMinderung	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	deutliche Vigilanzminderung mit Einschränkung von Schutzreflexen	Wenn Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
InvasivBlutdruck	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	invasive Blutdruckmessung	Wenn Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
SpeziDevices	Ja	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	spezielle Devices	Wenn Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
AnzahlPerfuser	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Anzahl der Perfusoren Einstellbar numerische Angabe (0 bis 9)	Wenn Kapitel "Erstbefunde/Verlegung" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: Einschätzung/Verlegungsarzt					Pflicht für NA-Protokolle, wenn bzw. Feld Einsatzort eine Verlegung mit physisch anwesendem NA oder ein Intensivtransport stattfindet. (Für RD-Protokolle ist dieses Kapitel nie Pflicht.)	Die Abhängigkeiten des gesamten Kapitels betreffen nur das Bundesland Baden-Württemberg Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Einsatzort GLEICH (05 ODER 07 ODER 08)	
IndikationArztbegleitung	Ja	E	Indikation Arztbegleitung gegeben	NA		Wenn Kapitel "Einschätzung/Verlegungsarzt" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
ZDringlichkeit	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Einschätzung der zeitlichen Dringlichkeit durch Transportarzt	Wenn Kapitel "Einschätzung/Verlegungsarzt" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Indikation?	Ja	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA	Indikation Intensivtransport	Wenn VBeatmung GLEICH 01 UND KatecholaminPflicht GLEICH 01, dann ist Code 00 unzulässig. Wenn Kapitel "Einschätzung/Verlegungsarzt" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 00 sind unzulässig.	-2

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: Diagnosen					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt oder ein physisch anwesender NA primär mitalarmiert oder nachgefordert wurde. Hinweis für BW: Wenn eine Diagnose, für die ein Indikator zur Eignung der Zielklinik oder zur leibnengerechten Versorgung dieser Diagnose existiert, im Diagnosen-Feld dokumentiert ist, wird auch eine entsprechend geeignete Zielklinik und leibnengerechte Versorgung erwartet. Eher unwahrscheinliche Differentialdiagnosen sollen im Einleitend dokumentiert werden.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) UND NotarztNachgefordert GLEICH 02 UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 08)	
Diagnose	Ja	M	Verdachtsdiagnose(n) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hier sollen nur einsatzrelevante Diagnosen und keine Vorerkrankungen dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notärztin/des Notarztes bzw. der Notfallsanitäterin/des Notfallsanitäters + Verstorbene Patienten können mit 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand oder 1813 + SIDS codiert werden. + Bei einer Anaphylaxe Grad 4 soll zusätzlich die Diagnose 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert werden. + Bei indirekten Verletzungen soll zusätzlich die Diagnose 1220 + Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert werden. + Bitte die Differenzierung zwischen hypertensivem Notfall (mit Organschäden und Lebensgefahr, z.B. AP-, Beschwerden, Lungenödem, neurologische Symptome) und hypertensiver Engbrüstigkeit (ohne Organschäden/Lebensgefahr) beachten!	Wenn Kapitel "Diagnosen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Kapitel: VerletzungenDetails					Pflicht für NA- und RD-Protokolle, wenn mindestens eine Verletzung aus Diagnosecodes mit führender 2 vorhanden.	Pflicht wenn: Mindestens ein Diagnose-Code GLEICH 2mm	
Verletzungsmuster	Ja	E	Verletzungsmuster Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Polytrauma: Gleichzeitig entstandene Verletzungen mehrerer Körperregionen oder Organsysteme, wobei wenigstens eine Verletzung oder die Kombination mehrerer lebensbedrohlich ist.	Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Unfallsache	Ja	E	Unfallsache Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Unfallmechanismus	Ja	M	Unfallmechanismus Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
Unfallhergang	Ja	M	Unfallhergang Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Kombinationen mit 99 sind unzulässig Wenn Kapitel "VerletzungenDetails" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
HelmPat	Nein	E	Helm Patient Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Hat der/die Verunfallte zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm getragen?	Kombinationen mit 99 sind unzulässig	-2
Kapitel: Scores					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine Hilfestellung, eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels oder um eine Verlegung mit physisch anwesendem Notarzt handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (05 ODER 08) UND EinsatzArt NICHT (03 ODER 07 ODER 08)	
NACAScore	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Subjektive Einschätzung der Schwere der Erkrankung oder Verletzung durch das rettungsdienstliche Personal. Es gilt die jeweils schlimmste Ausprägung im Einsatzverlauf.	Wenn Kapitel "Scores" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
MNACAScore	Nein	E	M-NACAScore Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Objektivierung des NACA-Scores. Soll aus dokumentierten Feldern berechnet werden!		-2

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: RDMassnahmen					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt oder ein physisch anwesender NA primär mitalarmiert oder nachgefordert wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) UND Notarzthilfsgefordert GLEICH 02 UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 08)	
Airway	Ja	M	Airway Maßnahmen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei vorbestehendem Tracheostoma ohne eigene Maßnahmen soll "keine Maßnahmen durchgeführt" codiert werden	Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
Atemunterst	Ja	M	Atemunterstützung - Beatmung Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
CirculationZugang	Ja	M	Medikamentenzugang Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
SpecMassen	Ja	M	Spezielle Maßnahmen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
EKG12Kanal	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Dokumentation eines 12-Kanal-EKGs Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht bei dokumentiertem ACS, STEMI oder Thoraxschmerz unklarer Genese	Pflicht wenn: Diagnose ENTHÄLT (1201 ODER 1202 ODER 1203 ODER 1204) Wenn EKG12Kanal Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Medizintechnik	Ja	M	Medizintechnik Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Kombinationen mit -1 sind unzulässig. Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
LagTrans	Ja	M	Lagerungs- und Rettungstechnik Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Mit HWS-Immobilisation ist nicht nur die Anlage einer Cervicstütze gemeint, sondern auch andere Methoden der Immobilisation wie z.B. Headblocks	Kombinationen mit -1 sind unzulässig. Wenn Kapitel "RDMassnahmen" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
DurchfHeilkundMacon	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Durchführung heilkundlicher Maßnahmen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	RD	Hiermit sind durchgeführte heilkundliche Maßnahmen durch Notfallsanitäler gemeint	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH RD UND DokRM GLEICH (02 ODER 15) Wenn DurchfHeilkundMassen Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Behandlungsgrad	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	RD	Hier soll dokumentiert werden, welcher Behandlungsgrad genutzt wurde (jeweils Standardarbeitsanweisungen, Algorithmen, Handlungsempfehlungen etc. nach örtlicher Vorgabe)	Kombinationen mit 03 sind unzulässig. Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH RD UND DurchfHeilkundMassen GLEICH (01 ODER 02) Wenn Behandlungsgrad Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: MedikamentöseTherapie					Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport, eine primäre Todesfeststellung (ohne CPR), eine Hilfeleistung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt oder ein physisch anwesender NA primär mitalarmiert oder nachgefordert wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND KeinTranspMiPat NICHT (02 ODER 05 ODER 08) UND Notarzthilfsgefordert GLEICH 02 UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 08)	
Medikamentengabe	Ja	M	Medikamentencodes für Art des Medikaments und Applikationsweg Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Nur einsatzrelevante Medikamente dokumentieren. Auch eine Vorbehandlung durch Andere soll dokumentiert werden, da diese für verschiedene Indikatoren relevant sein kann (für jede Medikamenten-Gruppe separat dokumentierbar).	Wenn Kapitel "MedikamentöseTherapie" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 99999 sind unzulässig.	-2
Infusionsgabe	Ja	M	Medikamentencodes für Art der Infusion und Applikationsweg Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Dauermedikation und Verabreichung durch Andere (Hausarzt, andere Rettungsmittel etc.): re97xx Nur einsatzrelevante Medikamente dokumentieren Dauermedikation und Verabreichung durch Andere (Hausarzt, andere Rettungsmittel etc.): re97xx	Wenn Kapitel "MedikamentöseTherapie" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 99999 sind unzulässig.	-2

Kapitel-/Eldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Kapitel: AbschlussBefundeBT			Abschlussbefunde bei Transport		Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat. Sofern der dokumentierende NA den Transport nicht begleitet, müssen die Befunde zum Zeitpunkt der Übergabe an das andere Rettungsmittel dokumentiert werden (z.B. für Feld On-Fall-Lesung u.d.R. 15 = Einsatzstelle). Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfand und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern allenfalls durch einen Telearzt begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AездBegleit ENTHÄLT 00 ODER 01 UND AездBegleit ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98) UND EinsatzArt NICHT 10	
Bewusstsein2	Ja	E	Bewusstseinslage Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
GlasgowComaScale2	Ja	E	Glasgow Coma Scale Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei Seitendifferenz bessere Seite.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
NeurologischeAuffälligkeiten2	Ja	M	Neurologische Auffälligkeiten Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	+ eNWS-EMS Items und BEFAST werden abgebildet. + die Dokumentation von Schweregraden und der Körperseite ist im MIND nicht vorgesehen	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit 00, -1 oder 99 sind unzulässig.	-2
SystemischerBlutdruck2	Ja	E	Systemischer Blutdruck Messwert in mmHg Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet RR-Messung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EKGbefund2	Ja	M	EKG-Befund Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sollten bei Erhebung der Abschlussbefunde mehrere Befunde zutreffen, ist eine Mehrfachauswahl möglich (hier jeden keine Ausprägungen dokumentiert werden, die vorher im Verlauf des rettungsdienstlichen Einsatzes zutreffend waren und nicht mehr vorhanden sind). Für QS wird EKG als durchgeführt gewertet, wenn Angabe ungleich -1.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig Kombinationen mit -1 oder 99 sind unzulässig.	-2
Herzfrequenz2	Ja	E	Herzfrequenz Messwert in /min Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Vom Monitor abgelesene Herzfrequenz pro Minute (ggf. palpatrisch oder pulsoximetrisch bestimmte Pulsfrequenz, wenn kein EKG abgeleitet wurde).	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Wenn EKGbefund2 GLEICH 09, dann sind Werte GRÖßER 0 unzulässig.	-2
Atemfrequenz2	Ja	E	Atemfrequenz Messwert in /min Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Ausgezählte oder vom Monitor abgelesene Atemfrequenz pro Minute.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Wenn Atmung2 GLEICH 08, dann sind Werte GRÖßER 0 unzulässig.	-2
Sauerstoffsättigung2	Ja	E	Sauerstoffsättigung Messwert in % Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Dieser Wert wird ggf. unter Sauerstofftherapie gemessen Bedeutet Pulsoxymetrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999.	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Schmerzempfinden2	Ja	E	Schmerzempfinden nach Numerischer Rating Scale (NRS) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Atmung2	Ja	M	Klinische Befunde Atmung Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sollten bei Erhebung der Abschlussbefunde mehrere Befunde zutreffen, ist eine Mehrfachauswahl möglich (hier jeden keine Ausprägungen dokumentiert werden, die vorher im Verlauf des rettungsdienstlichen Einsatzes zutreffend waren und nicht mehr vorhanden sind).	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Psyche2	Ja	M	Psychischer Zustand Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sollten bei Erhebung der Abschlussbefunde mehrere Befunde zutreffen, ist eine Mehrfachauswahl möglich (hier jeden keine Ausprägungen dokumentiert werden, die vorher im Verlauf des rettungsdienstlichen Einsatzes zutreffend waren und nicht mehr vorhanden sind).	Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Kombinationen mit -1, 00 oder 99 sind unzulässig.	-2
Pupillenweite2	Ja	E	Pupillenweite Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Lichtreaktion2	Ja	E	Lichtreaktion Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Kapitel "AbschlussbefundeBT" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Pausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
SoStTransport	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Sondersignal bei Transport: Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sondersignaleverwendung des transportierenden Rettungsmittels. Bei Patienten-Transport durch Hubschrauber: 01 = Ja Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patienten-Transport stattgefunden hat, der durch den dokumentierenden NA begleitet wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patienten-Transport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern ebenfalls durch einen Telenotarzt begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt...	Wenn Kapitel "AbschlussbefunddBTV" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 07 ODER 13) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit GLEICH 01 ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (05 ODER 06) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit GLEICH 02 ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 03) UND AertzBegleit ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98) UND EinsatzArt NICHT 10	-2
OPPaUeberg	Ja	E	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Der Ort, an dem der Patient primär übergeben wird. Sollen mehrere Auswahlmöglichkeiten zutreffen, ist die für die Weiterversorgung des jeweiligen Patienten spezifischste anzugeben. Sofern der dokumentierende NA den Transport nicht begleitet, ist i.d.R. 15 = Einsatzstelle zutreffend.	Wenn Kapitel "AbschlussbefunddBTV" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: AbschlussBefunddBTV			Abschlussbefunde bei Transport und ambulanter Versorgung		Pflicht für NA- und RD-Protokolle, wenn die Diagnose Hyponyktämie gestellt wurde oder wenn eine Atemwegsicherung oder eine maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) stattgefunden hat	Pflicht wenn: Airway GLEICH (03 ODER 05 ODER 07) ODER Atemunterst GLEICH 05 ODER Diagnose ENTHÄLT 1001 (Hyponyktämie) Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Pausibilitätsprüfungen.	
Blutzuckerwert2	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Blutzucker Messwert in mg/dl bzw. mmol/l Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Blutzuckermessung durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich: 557, 568 oder 599	Bei Auswahl 0 bis 500 bzw. 0,0 bis 50,0 wird BlutzuckerEinheit zum Pflichtfeld Pflicht wenn: Diagnose ENTHÄLT 1001 Wenn Blutzuckerwert2 Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
EiCO2Wert2	siehe Hinweise/ Pausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	etCO ₂ Wert (zuletzt unter Beatmung in mmHg gemessen) Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet Kapnometrie durchgeführt, wenn Angabe im Wertebereich oder 999. Pflicht wenn Atemwegsicherung oder maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) dokumentiert	Pflicht wenn: Airway GLEICH (03 ODER 05 ODER 07) ODER Atemunterst GLEICH 05 Wenn EiCO2Wert2 Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
Kapitel: Zielklinik					Pflicht für NA-Protokolle, wenn es sich bei dem dokumentierenden Rettungsmittel um ein luftgebundenes notarztbesetztes Rettungsmittel handelt, ein Patienten-Transport stattfindet und der Notarzt den Transport begleitet oder der RTW den Transport ohne ärztliche Begleitung durchführt. Pflicht für NA-Protokolle, wenn es sich bei dem dokumentierenden Rettungsmittel um ein luftgebundenes notarztbesetztes Rettungsmittel handelt, ein Patienten-Transport stattfindet und der Notarzt den Transport begleitet oder der RTW den Transport ohne ärztliche Begleitung durchführt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patienten-Transport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern ebenfalls durch einen Telenotarzt begleitet wird	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 07 ODER 13) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 01) ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (05 ODER 06) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 02) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBegleit ENTHÄLT (00 ODER 03) UND AertzBegleit ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98)	

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
NummerZK	Ja	E	Kennung der Zielklinik Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Standortnummer nach §293 Absatz 6 SGB V aus dem bundesweiten Verzeichnis der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen. Falls nur die Standort-ID bekannt ist (= erste 6 Stellen der Standortnummer) ist diese nach der 6. Stelle mit "0" (Null) auf 9 Stellen aufzufüllen: Standortnummer (9-stellig: 77nnnnnn) oder Standort-ID (6-stellig: 77nnnn000) der Zielklinik. Einmalige Anlage aller regelhaft angefahren/angeflogenen Krankenhäuser der Akutversorgung in Stammdatenbank erforderlich. Für Einrichtungen ohne Standortnummer müssen auf örtlicher Ebene alternative Definitionen getroffen werden.	Wenn Kapitel "Zielklinik" Pflicht, dann ist -2 unzulässig.	-2
AnmeldungPatient	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Wurde der Patient in der Zielklinik angemeldet? Muss bei Patiententransport angegeben werden, auch wenn die Anmeldung durch die Leitstelle erfolgt. Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Patientenanmeldung durch Fahrzeugbesatzung oder Leitstellenpersonal. Mindestens einmal pro Patient erforderlich. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat, der durch den dokumentierenden NA begleitet wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch anwesenden Notarzt, sondern allenfalls durch einen Telenotarzt begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt.	Wenn Kapitel "Zielklinik" Pflicht, dann ist -2 unzulässig. Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 07 ODER 13) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBoglet GLEICH 01 ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DokRM GLEICH (05 ODER 06) UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBoglet GLEICH 02 ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDtransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND AertzBoglet ENTHÄLT (00 ODER 03) UND AertzBoglet ENTHÄLT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 96) UND EinsatzArt NICHT 10	-2
Kapitel: EinsatzBesonderheiten						Pflicht wenn: EinsatzArt NICHT (11 ODER 12)	
EinsatzBesonderheiten	Ja	M	Einsatzbesonderheiten Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	+ Abweichung von medizinischen Standards, + Abweichung vom Zielablauf, + erhöhter Aufwand. Ablehnung induzierter Maßnahmen (z.B. Diagnostik, Therapie) durch Patienten: 02. Transportverweigerung ist im Feld KeinTranspMitPat zu dokumentieren (04 = Patient lehnt Transport ab). Pflicht, außer für Dienstfahrten und Pauseneinsätze	Kombinationen mit 03 sind unzulässig.	-2
PreEmergencyStatus	Nein	E	Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Schwere der Vorerkrankungen, Zustand vor Eintritt des Notfalls. Pflicht für NA-Protokolle, wenn die Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand, ein SIDS, eine primäre Todeserkrankung (ohne CPR) oder "Patient im Einsatzverlauf verstorben" dokumentiert wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn die Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand dokumentiert wurde, oder bei einer Todeserkrankung bzw. einer Dokumentation des Todes im Einsatzverlauf, aber nur wenn eine Notfallmeldung ohne erkennbare primäre NA-Einschaltung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND (Diagnose ENTHÄLT (1230 ODER 1813) ODER KeinTranspMitPat GLEICH (02 ODER 03)) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND (Diagnose ENTHÄLT (1230 ODER 1813) ODER KeinTranspMitPat GLEICH (02 ODER 03)) UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 98)	-2
Kapitel: Reanimation							
Reanimationsituation	Ja	E	Wurde eine Reanimation durchgeführt? Wertefeld siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Eine begonnene Reanimation ist mit 01 oder 02 oder 03 zu dokumentieren. Bei primärer Todesfeststellung (ohne CPR) ist nur "Reanimation nicht durchgeführt..." zulässig. Ohne Patientenkontakt ist nur "keine Reanimationsituation (kein Tod/kein Kreislaufstillstand)" zulässig. Bei Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand oder SIDS bzw. bei Dokumentation "Patient im Einsatzverlauf verstorben" ist "keine Reanimationsituation (kein Tod/kein Kreislaufstillstand)" unzulässig.	Triggerfeld für Dokumentationsumfang und Plausibilitätsprüfungen. Wenn KeinTranspMitPat GLEICH 02, dann ist Reanimationsituation GLEICH (00 ODER 01 ODER 02 ODER 03 ODER 94) unzulässig. Wenn RDtransport GLEICH 02, dann ist nur Reanimationsituation GLEICH 00 zulässig. Wenn Diagnose ENTHÄLT (1220 ODER 1813) ODER KeinTranspMitPat GLEICH 03 dann ist Reanimationsituation GLEICH 00 unzulässig.	-2
Kapitel: ReanimationDetails					Pflicht für NA-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsmittel Reanimation durchgeführt hat. Pflicht für RD-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsmittel Reanimation durchgeführt hat und eine Notfallmeldung ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationsituation GLEICH (01 ODER 02 ODER 03) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationsituation GLEICH (01 ODER 02 ODER 03) UND EinsatzArt GLEICH (02 ODER 04 ODER 06 ODER 98) UND NotarztNachgefordert GLEICH 02	

Kapitel-/Feldname	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	Einfach-/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	Teildatensatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Reanimations technik	Ja	M	Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD		Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
URKRSTST	Ja	E	Vermutete Ursache des Kreislaufstillstandes Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Die internationalen Vorgaben des Utstein-Style Protokolls unterscheiden die Ursachen eines Kreislaufstillstandes in mehreren Sektionen. Gefragt ist die aus Sicht des Notarztes vermutliche Ursache.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
SPORT	Nein	E	Zusammenhang mit sportlicher Aktivität: Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeht ein Zusammenhang des Kreislaufstillstandes mit sportlicher Aktivität?	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZEQFR	Nein	E	Zeitstempel Eintreffen First Responder Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Eintreffzeit eines First Responders als "Vorausversorger" neben dem regulären Rettungsdienst am Einsatzort.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+0
ZCKB	Ja	E	Person Kollaps beobachtet Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wer hat den Kollaps beobachtet? Erstshelfer entspricht dem nichtmedizinischen Personal bzw. Laien.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZCHDM	Ja	E	Person Herzdruckmassage begonnen Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wer hat mit der Herzdruckmassage begonnen bzw. den Beginn angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu dokumentieren.)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZCDEFI	Ja	E	Person Defibrillation durchgeführt Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wer hat die erste Defibrillation durchgeführt bzw. angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu kodieren.)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
ZHDM	Ja	E	Zeitpunkt Beginn Herzdruckmassage Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Erster Zeitpunkt, zu dem mit der Herzdruckmassage begonnen wurde, ggf. schätzen.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+0
ZDEFI1	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Zeitpunkt erste Defibrillation Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Zeitpunkt der ersten Defibrillation. Pflicht für NA-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW, RTW oder NA dokumentiert wurde Pflicht für RD-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW oder RTW dokumentiert wurde und eine Notfallleitung eine erkennbare NA-Beteiligung bzw. -Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND ZCDEFI GLEICH (04 ODER 05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND ZCDEFI GLEICH (04 ODER 05) UND Einsatzart GLEICH 02 ODER 04 ODER 06 ODER 08 UND NotarztNachgefordert GLEICH 02 Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+0 1:00
ZROSC1	siehe Hinweise/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	E	Zeitpunkt 1. ROSC Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Bei Wiedereintritt eines Eigenkreislaufs (ROSC) ist die Zeit zu notieren. Ab diesem Zeitpunkt hat der Patient einen eigenen Kreislauf mit einem messbaren Puls. Auch wenn dieser wieder zusammenbricht, ROSC = return of spontaneous circulation (Spontankreislauf)	Pflicht wenn: ROSC GLEICH 02 Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer "1902-02-02T00:00:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+0 1:00
ROSC	Ja	E	Erreichen eines Spontankreislaufs Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Könnte durch die Reanimationsmaßnahmen jemals ein spontaner Kreislauf > 20 Sekunden etabliert werden? Wenn bei Feld KHAUF "Krankenhausaufnahme mit ROSC", dann in Feld ROSC nur "jemals ROSC" zulässig.	Wenn KHAUF GLEICH 02, dann nur ROSC GLEICH 02 zulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
KHAUF	Ja	E	Patientenzustand bei Krankenhausaufnahme Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Zustand bei Übergabe an die Zielklinik.	Wenn Reanimations situation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig. Wenn Reanimations situation GLEICH (05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer 01 unzulässig.	-2
ZTOD	Nein	E	Zeitpunkt TOD Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Beendigungszeitpunkt der Reanimationsmaßnahmen.	Wenn Reanimations situation GLEICH (00 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08), dann sind alle Werte außer "1902-02-02T00:00:00" unzulässig.	1902-02-02T22:00:00.000+0 1:00
ende							